EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL	:	HOSPITAL DE SAN CARLOS	N° EGRESO	:	71789
SERVICIO	:	MEDICINA HSC			
FECHA	:	2023-10-04 11:42:00			

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: VICENTE GONZALEZ DURAN			RUN	: 9.101.054-2
F.Nac	: 05-01-1960	Edad	: 63 AÑOS, 8 MESES	Género	: Masculino
Dirección	:			Comuna	: SAN NICOLAS
Previsión	: SIN INFORMACION	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 2023-09-17	Fecha Egreso	: 2023-10-04 11:42:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. J15-NEUMONIA BACTERIANA, NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1. INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA GLOBAL (RESUELTA)
2. NEUMONÍA MULTIFOCAL EN PACIENTE INMUNOSUPRIMIDO
3. CARCINOMA ESCAMOSO DE PISO DE BOCA
4. EPOC
5. BICITOPENIA:

A. ANEMIA MODERADA MACROCITICA-NORMOCRÓMICA
B. TROMBOCITOPENIA LEVE

6. DELIRIUM

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. J96.0-INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)
2. J15.9-NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
3. C04-TUMOR MALIGNO DEL PISO DE LA BOCA (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
4. J44-OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES OBSTRUCTIVAS CRONICAS (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
5. D64.9-ANEMIA DE TIPO NO ESPECIFICADO (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
6. F05-DELIRIO,NO INDUCIDO POR ALCOHOL U OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTI (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
7. I10-HIPERTENSION ESENCIAL(PRIMARIA) (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
8. E11-DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Antecedentes: HTA, DMT2 NIR. Ca escamoso de piso de boca Etapa IVa desde Feb´23 con extenso compromiso mandibular izquierdo, moderadamente indiferenciado, localmente avanzado por compromiso oseo y extensión a partes blandas de cuello y adenopatías, sin MTT, en cuidados paliativos y seguimiento por oncología, cumplió QMT (3 ciclos) hasta Mayo´23 con buena respuesta, en espera de radioterapia. Tabaquismo activo.
Paciente masculino de 63 años con antecedentes de Carcinoma escamoso de piso de boca, quien es traído por familiar por presentar aproximadamente 7 días de evolución de CEG, decaimiento, hiporexia y acentuación del patrón de tos habitual, niega fiebre. Ingresa a urgencias en malas condiciones generales, afebril, con tendencia a la hipotensión, taquicárdico, polipneico con UMA (+) desaturando a 60% con ruidos respiratorios audibles, somnoliento, se inicia manejo con apoyo de O2 por MAF, aporte de volumen, corticoide y broncodilatación, en exámenes destacan parámetros inflamatorios elevados, leucocitosis, falla renal aguda con creat 1.7 (basal 1.0) acidosis respiratoria descompensada y DD elevado, realizan AngioTC de tórax (-) TEP con neumonía multifocal. En urgencias se inicia apoyo con VMNI, con buena respuesta, mejora mecánica respiratoria, menores req de O2 y mejora nivel de conciencia con GCS 15pts. Tras revisión de caso y antecedentes se decide traslado a UCI para manejo con VMNI hasta establecer proporcionalidad terapéutica según expectativa de vida en contacto con oncólogo tratante. Se deja con tto atb empírico en contexto de paciente imunosuprimido se decide escalar y se adiciona trimetropin/sulfametoxazol. Completa tratamiento en UTI y es trasladado a sala común. Con parámetros inflamatorios he infecciosos bajos, presenta episodio de agitación y se desorienta, se maneja con médico residente. Actualmente estable por más de 48 horas, se indica HODOM para seguimiento con fono + knt y control poli otorrino. Se realiza educación del manejo SNG a hija y cuidados respectivos.

INDICACIONES AL ALTA

1. REPOSO RELATIVO ASISTIDO CON CABEZARA 30°
2. REGIMEN POR SNG
3. HIDRATACION POR SNG
4. QUETIAPINA COMPRIMIDO 25 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 24 hrs. Noche SOS por SNG
5. BISOPROLOL COMPRIMIDO 2,5 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 24 hrs por SNG
6. OMEPRAZOL COMPRIMIDO 20 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 24 hrs. por SNG

7. Seguimiento fonoaudiolgia
8. KNT M + R
9. Control poli otorrino por NEO

CAMILA COLLAO ITURRA
MEDICO TRATANTE
19088566-6

JEFE SERVICIO